



研究认为：应杜绝严重的药物相互作用

Carol Ukens

根据亚利桑那大学研究员们介绍，零售药剂师为存在漏洞的药物预警程序做了大量的信息补充工作，同时建议，当遇到严重药物相互作用时，药剂师应该从更多渠道获得参考信息。

美国药师学会杂志最近公布的一项研究显示，药物—药物结合体是病人最危险的敌人这一说法并没有取得广泛共识。亚利桑那大学药学院及在 Jacob Abarca 领导下的公共卫生研究人员发现，在一份或者四份以上的统计资料中所提到的 406 种临床上最重要的药物相互作用例子中，只有 9 例是在四者中都出现的。实际上，71% 的主要药物相互作用来源于其中一个资料来源。所研究的四项内容包括：药物相互作用案例；药物相互作用：分析和处理；药物相互作用评价以及 MICROMEDEX DRUG-REAX 项目。

参加此项研究的 Daniel Malone 副教授说：“重要的临床药物相互作用组成中的重大变化远远超过我们的预期值。因此，我们建议药师在下结论前，不能只依靠一种数据来源而做出决定，应得到全部的信息、核对多种数据来源，尤其是应核对其准确性。”

Malone 承认，从某种程度上讲，零售药剂师有时候会被药店里使用的药物预警软件所蒙蔽。但他补充到“尽管不可能记住所有药物相互作用(DDI)，但药剂师应该具备一定的药物相互作用的知识，这就是为什么我们开始试着确定那些非常重要的 DDI”。

一项合作研究是由专家来总结零售和门诊药剂师可能遇到的最重要的临床 DDIs (见右表)，Malone 是此项研究的首席研究员。他解释说，专家们希望这项研究能一直进行下去，列表中已有 10 至 15 种 DDIs，数目在迅速增加，直到有 25 种才可能停止。关于 DDIs 的这项研究是由疾病控制和预防中心资助的，它关注药房预警系统，从开具处方者(比如药剂师)是否称职，到是否忽视了重要警告。

Malone 同时还表示，这个列表不可能包括所有的 DDIs，这只是一个开始。另外，这对人们理解这些 DDIs 不是绝对的禁忌很重要。医生或药师不必阻止患者合并使用这些药物，因为其中有一些药物能够很好地控制剂量、患者很好地接受治疗监测或者很多患者已经知道去预防潜在的危险。

Malone 建议，医院中的药剂师可以对照专家给出的 25 种严重的 DDIs 检查他们的药房预警系统。他还补充“如果这些药物没有作为重要的药物相互作用被列出，他们应该修改他们的系统或要求系统的销售者进行修改”。Malone 副教授说，药剂师在鉴定药物相互作用和与医生交流的工作中很出色，他们在提供信息的工作中同样做得很出色。我们未来的一些研究将着眼于改善 DDI 预警系统的方法，以确保可以将信号从噪音中分离。(编译 国家药典委员会 周怡)

药物相互作用及临床重要性*	
受变药物分类	促变药物分类
抗凝血剂(茴香二酮、双香豆素、华法林)	甲状腺激素类(左甲状腺素, 碘赛罗宁, liotrix, 右旋甲状腺素)
苯二氮草类(阿普唑仑, 三唑仑)	唑咯类抗真菌剂(氟康唑, 伊曲康唑, 酮康唑)
卡巴咪唑	丙氧酚
环孢霉素	抗结核类(利福平, 利福布丁, 利福喷丁)
右甲吗南	单胺氧化抑制剂[异(恶)唑(酮)肼, 苯乙肼, 司立吉林, 反苯环丙胺]
异羟洋地黄毒苷	克拉霉素
麦角碱生物碱(双氢麦角胺, 麦角胺, 二甲麦角新碱)	大环内酯类抗生素(克拉霉素, 红霉素, 竹桃霉素)
雌孕激素产品(口服避孕药)	利福平
更昔洛韦	齐多夫定
单胺氧化抑制剂	厌食剂; 交感神经作用剂
盐酸麦角里定	单胺氧化抑制剂
甲氧氯普	甲氧苄啶(甲氧苄啶-磺胺甲异恶唑, 甲氧苄氨嘧啶)
硝酸盐(硝酸甘油, 硝酸异山梨酯/单硝酸异山梨酯)	西地那非
匹莫齐特	大环内酯类抗生素; 唑咯类抗真菌剂
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 SSRIs (西酞普兰, 氟西汀, 氟伏沙明, 奈法唑酮, 舍曲林, 文拉法辛)	单胺氧化抑制剂
茶碱	喹诺酮类(环丙沙星, 依诺沙星); 氟伏沙明
硫嘌呤类[噻唑硫嘌呤, (噻基)噻唑硫嘌呤]	别嘌醇
华法林	磺吡酮; 非甾体类抗炎药; 西咪替丁; 纤维酸衍生物; 巴比妥类

*作者指出此列表目的不在于列出所有严重的药物相互作用, 改编自“严重的药物相互作用的鉴别: 防止药物相互作用的结论”, 美国药师学会杂志, 3月/4月, 2004, Vol. 44, No. 2.
美国药师学会 (APhA) 版权所有, 再版需取得美国药师学会许可。

乳腺癌的循环癌细胞转向个体化治疗？

Stephan Braun, Christian Marth

当 Steven Paget 于 1889 年发表“种子与土壤”理论时, 产生了癌细胞血行转移的概念。一个多世纪后, 随着分子工具的应用, 新的临床研究发现已经能解释之前无法解释的现象, 例如: 在受体移植器官中易发生癌变; 转移灶的所有癌细胞均是已知原发性肿瘤的“子孙”和此后转移灶的“原祖”。Cristofanilli 等人报道, 现在循环癌细胞的实验室分析能够使我们提早预测疗效。

Cristofanilli 的研究进展

这项研究的主要成就是: 在转移性疾病患者开始治疗 3~4 周后就能够预测治疗效果, 因而对个体化治